

Juzgado Federal de Ushuaia Sres: Defensoria Pública Federal

Av: Maipu n° 727 1° piso

1

Laboratorio de hisocompatibilidad.

2

Historia clínica paciente Gustavo Dip.

3

Copia de dni Romero Carlos.

4-5

Copia de afiliado obra social "pami".

6

Certificado tratamiento de diálisis.

7-8-9

Resumen de historia clínica.

10

Constancia de inscripción en lista de espera.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LISTA DE ESPERA

Cordoba, martes 28 de febrero de 2023

CARLOS DANIEL ROMERO
LOS TEROS Nº53
(5152) VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

El día LUNES 27 de JUNIO de 2022 a las 14:06 hs, habiendo concluido todos los estudios y exámenes médicos de la evaluación pretrasplante órgano/tejido requeridos, y como resultado de dicha evaluación, el Dr. JORGE LUIS DE LA FUENTE de la Institución HOSPITAL PRIVADO DE CORDOBA ha considerado **APTO PARA TRASPLANTE** al paciente CARLOS DANIEL ROMERO, DNI: 16178394.

El financiador(INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI)) ha dado la autorización de financiamiento para trasplante.

El organismo jurisdiccional ECODAIC, responsable de la inscripción, tomó intervención en la fiscalización de los procesos administrativos y certifica que se han cumplido todos los requisitos médicos y legales;

Queda concluido el proceso de inscripción #439537

Se deja constancia,

Que el potencial receptor CARLOS DANIEL ROMERO, DNI: 16178394, **queda inscripto en LISTA DE ESPERA PARA TRASPLANTE RENAL.**

RESUMEN de inscripción en Lista de Espera

Número de inscripción: **439537**

Lista de espera para trasplante: **RENAL**

Situación clínica: **ELECTIVO - VIGENCIA: 27-06-2022**

Potencial receptor: **CARLOS DANIEL ROMERO**

Domicilio del potencial receptor: **LOS TEROS Nº53**

Fecha de ingreso a Lista de Espera: **LUNES 27 de JUNIO de 2022 a las 14:06 hs**

Organismo fiscalizador: **ECODAIC**

INCUCAI: **0800-555-4628 (Área Atención a Pacientes)**

Firma y aclaración

Dr. EDMUNDO VIDELA
COORDINADOR MÉDICO
FRESENIUS MEDICAL CARE
ARGENTINA S.A.
ESP. NEFROLOGÍA Y MEDIO INTERNO
M.P. 24336/6 - M.E. 8928



ROMERO, CARLOS (ARGCR028130)

DATOS PERSONALES

Apellidos:	ROMERO	Nombres:	CARLOS DANIEL		
País de nacimiento:	Argentina	Fecha de nacimiento:	11/05/1963	Edad:	59
Tipo de documento:	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)	Número de documento:	16178394	Raza:	
Estado civil:		INCUCAI:		Sexo:	Masculino
Cobertura:	INST. NACIONAL DE SERV. SOCIAL PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS - INSSJP - PAMI (54440034)	Afiliado nro.:	140056835204/00		
Dirección:	TOMAS GUIDO 2160 BARRIO LOMAS DE SAN MARTIN	Ciudad:	CORDOBA		
Teléfono:	2901 54-2389 ESPOSA MARCELA, 351-2938999 GUSTAVO / 263-4628484 amigo JUAN MOYANO	Teléfono de Contacto:			
Médico cabecera:		Teléfono del médico:			
Código de HC:	ARGCR028130	Celular			
Etiología precisa de la IRCT (sólo para pacientes biopsiados):					
Estado de inscripción en lista de espera:		1. INSCRIPTO			
Número de inscripción en lista de espera:		439537			

MOVIMIENTOS:

Fecha	Tipo	Situación del paciente	Centro relacionado con el Movimiento
27/12/2022	Regreso del tránsito	Hemodiálisis	Centro de HD en Usuahia
04/10/2022	Egreso de tránsito a otras clínicas	Ausente por transito	Centro de HD en Usuahia
30/08/2022	Regreso del tránsito	Hemodiálisis	ARGSF51 - FME SANTA FE
27/08/2022	Ingreso de tránsito	Temporario	ARGCR02 - FME CORDOBA(2) - CASEROS
27/08/2022	Egreso de tránsito a clínica FME-EuCliD	Ausente temporalmente	ARGSF51 - FME SANTA FE
04/04/2022	Regreso del tránsito	Hemodiálisis	ARGSF51 - FME SANTA FE
04/04/2022	Fin del tránsito	Fin del periodo vacacional	ARGCR02 - FME CORDOBA(2) - CASEROS
02/04/2022	Ingreso de tránsito	Admisión por transito	ARGCR02 - FME CORDOBA(2) - CASEROS
02/04/2022	Egreso de tránsito a clínica FME-EuCliD	Ausente por transito	ARGSF51 - FME SANTA FE
08/02/2022	Cambio de modalidad a HD	Hemodiálisis	
08/02/2022	Reanudación del tratamiento	Temporario	
07/02/2022	Terminación de contrato	INACTIVO	
20/10/2021	Reactivación	Temporario	
09/06/2021	Fin del tránsito	Temporary finished	
19/05/2021	Admisión de Paciente nuevo	Temporario	

ANTECEDENTES PERSONALES - OTROS



ROMERO, CARLOS (ARGCR028130)

Grupo sanguíneo:

Grupo etiológico: enfermedad cardiorrenal
hipertensiva con
insuficiencia renal

Confirmado con biopsia: No

Motivo original de la consulta: HTA- Hiporexia-prurito y calambres
Cambio de centro por cambio de domicilio.

Primera diálisis en la vida: 31/10/2020

Antecedentes de la enfermedad actual: 20/10/2021

Paciente de 58 años de edad, oriundo de Ushuaia con antecedentes de HTA diagnosticada a los 45 años, mal manejo, IAM año 2005 con colocación de Stent(atc a DA), dislipemia severa, en seguimiento por nefrología desde año 2012 que se detecta deterioro de la función renal e HPB, año 2016 muy mal control de su HTA, mayor deterioro de la función renal, en año 2019 se detecta litiasis renal, en tratamiento con urología. desde año 2019 paciente con proteinuria grado nefrotico y clearance de creatinina de 20ml/min, mal control de su hipertensión arterial, incumplimiento de dieta, tratamientos propuestos y controles. En Septiembre de 2019 presento urgencia urológica por litiasis que requirió colocación de pig tail. Desde dicha fecha persiste importante deterioro de la función renal con elevación de productos nitrogenados. Año 2020 presenta astenia, hiporexia perdida de peso progresivas hasta que el 31/10/2020 debido a franca sintomatología uremica, en paciente sintomático y con perfil bioquímico de ERC estadio avanzado se decide su ingreso a tratamiento sustitutivo renal, hemodialisis, a través de cateter doble lumen subclavio derecho. Posteriormente mejora y queda en hemodialisis ambulatoria trisemanal en servicio de nefrología y hemodiálisis de Ushuaia desde noviembre 2020. El paciente presentó varios procedimientos urológicos por cateter pig tail calcificado, correcciones de medicación antihipertensiva por mal control de TA, Mayo 2021 pielotac con riñones disminuidos de tamaño y sin litiasis. Desde Agosto de 2021 con cobertura pami, presenta Sd de tunel carpiano. Paciente que asiste el día de la fecha en transito por 20 dias aproximadamente, luego regresara a su centro de origen para ultimar detalles de su traslado definitivo a cordoba.

ANTECEDENTES PERSONALES - COMORBIDAS

21/10/2012 I13.1 enfermedad cardiorrenal hipertensiva con
insuficiencia renal

ANTECEDENTES FAMILIARES

- No se registran datos

ALERGIAS

- No se registran datos

PROCEDIMIENTOS

Fecha	Prueba diagnóstica	Resultado	Observaciones	Resultado
16/02/2022	Otra prueba diagnóstica	88.75 - ULTRASONIDOS DIAGNOSTICOS DE APARATO URINARIO	Ambos riñones de forma normal, de pequeñas dimensiones, muestran borramiento cortico-medular, perdida del espesor parenquimatoso e incremento de la ecorrefringencia cortical, sin dilatación de los sistemas colectores, siendo sus diámetros: Riñón Derecho: 77mm longitudinal x 36mm anteroposterior y 40mm transversal Riñón Izquierdo: 83mm longitudinal x 36mm anteroposterior y 44mm transversal No se observan signos de litiasis ni retracciones corticales no masas sólidas ocupantes de espacio Interpretación: Criterios para nefropatía difusa de evolución crónica	Anormal
08/06/2022	Otra prueba diagnóstica	93.08 - ELECTROMIOGRAFIA		

CONSULTAS A ESPECIALISTAS

- No se registran datos

DATOS CLINICOS Y DEL TRATAMIENTO


ROMERO, CARLOS (ARGCR028130)

Fecha	25/02/2023
Turno	MJS 1er Turno
Sala	Sala 1
Duración del tratamiento (min)	250 min
Peso post-diálisis	84,4 Kg
Peso pre-diálisis	87,5 Kg
TAS pre-diálisis	140 mmHg
TAD pre-diálisis	80 mmHg
Temperatura corporal pre-diálisis (°C)	36 °C
Frecuencia cardíaca pre-diálisis (lpm)	82 lpm
Dializador utilizado	DIALIZADOR FILTRO FX800
Concentración de calcio en dializado (mEq/l)	3
Concentración de glucosa en dializado (mEq/l)	1
Tipo de buffer utilizado	BIBAG X 1050 G (5008)
Flujo del dializado (Qd, ml/min)	
Temperatura del dializado (°C)	36 °C
Sodio seteado en dializado (mEq/l)	
Dosis de heparina total diaria (UI)	8667 UI
Dosis de heparina a administrada en bolo (UI)	5000 UI
Flujo de sangre efectivo (Qbe, ml/min)	400 ml/min
Presión arterial pre-bomba (mmHg)	-225 mmHg
Presión venosa (mmHg)	210 mmHg
En este tratamiento se obtuvo muestra para laboratorio mensual?	No
Peso seco	83,5 Kg
TAS post-diálisis	120 mmHg
TAD post-diálisis	60 mmHg
Temperatura corporal post-diálisis (°C)	36 °C
Frecuencia cardíaca post-diálisis (lpm)	70 lpm
Notas de enfermería	estable - Registro ingresado con HRT. V 1.6.0.4

ULTIMOS RESULTADOS DE LABORATORIOS
Laboratorio Habitual

Hematocrito	42.40	%	
Hemoglobina	14.10	g/dl	
Recuento de globulos rojos	4.36	10 ⁶ /mm ³	
Reticulocitos	1.00	%	(12/2022)
Volumen corpuscular medio	97.25	µg ³	
Hemoglobina corpuscular media	32.34	pg	
Concentracion de hemoglobina corpuscular media	33.25	g/dl	
Volumen de Plaquetas	143.00	fl	(12/2022)
Leucocitos	7300.00	no./mm ³	
Plaquetas	143000.00	no./mm ³	
Eosinofilos	3.00	%	(12/2022)
Monocitos	8.00	%	(12/2022)
Calcio total	9.00	mg/dl	
Fosforo	5.40	mg/dl	
Producto fosfocalcico	48.60	(mg/dl) ²	
PTHi	286.00	pg/ml	(12/2022)
Sodio	138.00	mEq/l	
Potasio	4.30	mEq/l	
Glucemia	74.00	mg/dl	
AST (GOT)	10.00	UI/l	

**ROMERO, CARLOS (ARGCR028130)****Laboratorio Habitual**

ALT (GPT)	13.00	UI/l	
Bilirrubina total	0.50	mg/dl	(02/2022)
Bilirrubina indirecta	0.40	mg/dl	(02/2022)
Fosfatasa alcalina	62.00	UI/l	
Ferremia	58.00	µg/dl	(12/2022)
Transferrina	169.00	mg/dl	(12/2022)
Saturacion de Transferrina	35.00	%	(12/2022)
Ferritina	838.00	µg/l	(12/2022)
Creatinina serica	7.05	mg/dl	
Proteina C Reactiva (PCR)	1.40	mg/l	(02/2022)
Uricemia	8.40	mg/dl	(02/2022)
Albumina	3.99	g/dl	
Proteinas totales	7.22	g/dl	(09/2022)
Colesterol total	151.00	mg/dl	(12/2022)
Colesterol LDL	30.00	mg/dl	(02/2022)
Colesterol HDL	45.00	mg/dl	(02/2022)
Trigliceridos	340.00	mg/dl	(12/2022)
Urea pre-dialisis	99.00	mg/dl	
Urea post-dialisis	29.00	mg/dl	

Marcadores Serologicos

HBsAg	Negativo		(08/2022)
Anti-HBsAg (UI/l)	1000.00	UI/l	(08/2022)
Anti-HBcAg (IgG)	Negativo		(02/2022)
HCV Status (ELISA)	Negativo		(05/2022)
HIV Status	Negativo		(05/2022)
Chagas	Negativo		(02/2022)

Laboratorio Adicional

Citomegalovirus CMV IgG	237800.00	UI/l	(02/2022)
Toxovirus TOXO IgG	1.60	UI/ml	(02/2022)
VDRL	Negativo		(02/2022)

MEDICACION ACTIVA AL 28/02/2023**Medicación prescrita para diálisis**

02/02/2023	ÁCIDO FÓLICO	130 mg	10 mg, Número de tomas diarias: 1 (Por días de la semana: Martes, Jueves, Sábado)
03/01/2023	CALCIO CARBONATO (APORTE)	13 g	1 g, Número de tomas diarias: 1 (Por días de la semana: Todos los día)
03/01/2023	CALCITRIOL	6,5 µg/mes	0,5 µg, Número de tomas diarias: 1 (Por días de la semana: Martes, Jueves, Sábado)
02/02/2023	CALCITRIOL	6,5 µg/mes	0,5 µg, Número de tomas diarias: 1 (Por días de la semana: Martes, Jueves, Sábado)
02/02/2023	COMPLEJO VITAMÍNICO B NO ASOCIADO	13 UI	1 UI, Número de tomas diarias: 1 (Por días de la semana: Martes, Jueves, Sábado)
02/02/2023	HIERRO IV (MEDICAMENTOS ANTIANÉMICOS, HIERRO TRIVALENTE POR VÍA PARENTERAL)	100 mg/mes	100 mg, Número de tomas diarias: 1 (Número de diálisis en el mes: 3°)

Medicación domiciliaria

21/02/2022	ATORVASTATINA	10 mg	10 mg, Número de tomas diarias: 1 (Por días de la semana: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo)
21/02/2022	CARVEDILOL	12,5 mg	12,5 mg, Número de tomas diarias: 1 (Por días de la semana: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo)



ROMERO, CARLOS (ARGCR028130)

**ARGCR02 - FME CORDOBA(2) - CASEROS
CASEROS 1715
Cordoba (5000) Argentina
Telefono : (0351) 4885454 / 4885864**

11/05/2022	PREGABALINA	50 mg	50 mg, Número de tomas diarias: 1 (Por días de la semana: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo)
21/02/2022	VALSARTAN	160 mg	160 mg, Número de tomas diarias: 1 (Por días de la semana: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo)

EVOLUCION

11/02/2023	Paciente estable ,normotenso acceso vascular buen funcionamiento buen hto y hb sin EPO producto calcio fosforo bien
16/01/2023	Paciente estable , normotenso acceso vascular buen funcionamiento buen hto y hb sin EPO producto calcio fosforo bien
28/12/2022	Paciente que regresa de transito en Usuhaia . estable ,normotenso acceso vascular buen funcionamiento buen hto y hb sin EPO producto calcio fosforo bien
24/09/2022	Paciente estable ,normotenso acceso vascular buen funcionamiento buen hto y hb sin EPO producto calcio fosforo bien PTH 440 esta con calcitriol
23/08/2022	Paciente que comienza con hemodiafiltracion en linea
11/08/2022	Paciente de regreso de su estadia en Usuhaia donde se hemodializzo . normotenso estable acceso vascular buen funcionamiento paciente que continua con sintomas de polineuropatia en MMII que no mejoran con la medicacion pregabalina en dosis de 50 mg . presentando parestesias urentes en MMII , piernas inquietas que alteran el descanso nocturno . EMG con polineuropatia axonal en MMII , por lo que se solicita cambio de modalidad a hemodiafiltracion en linea como alternativa terapeutica para mejorara sintomatologia y calidad de vida .
21/07/2022	Paciente de transito en usuhaia
10/06/2022	Paciente estable ,normotenso acceso vascular buen funcionamiento buen hto y hb sin EPO hierro e.v producto calcio fosforo bien completo estudios pretrasplante en hosp. privado. se realiza EMG de MMII que informa polineuropatia axonal en MMII esta medicado con pregabalina en dosis de 50 mg a la noche con escasa mejoría de sintomatologia
21/05/2022	Paciente estable ,normotenso acceso vascular buen funcionamiento buen hto y hb producto calcio fosforo normal presenta síntomas de polineuropatia en MMII parestesias dolorosas sensación de piernas inquietas se solicita EMG y se indica pregabalina.
01/04/2022	Paciente estable ,normotenso acceso vascular buen funcionamiento turno para estudios pretrasplante en hospital privado paciente con parestesias dolorosas en MMII , sensacion de piernas inquietas por la noche se indica pregabalina 25 mg al acostarse.
03/03/2022	Paciente estable normotenso acceso vascular buen funcionamiento se entrega pedidos para sevelamer turno para estudios pretrasplante hospital privado en abril presenta parestesias dolorosas en MMII , piernas inquietas ,
18/02/2022	Paciente estable, se recibe laboratorio y se indica Hierro IV, presenta Hiperfosfatemia en tratamiento con carbonato de sevelamer, se realiza expediente para presentar en PAMI, se estudiara para trasplante en Hospital Privado de Córdoba.
08/02/2022	Paciente que decide cambio de residencia, se quedara a vivir en Córdoba, cambio de centro por ese motivo, estable.

INTERNACIONES

- No se registran datos

ACCESOS VASCULARES

Tipo de acceso	Localización & Anastomosis	Fecha de creación	Fecha de 1er uso	Fecha de ultimo uso
Fistula	RADIO-CEFALICA IZQ DISTAL	14/12/2020	15/01/2021	En uso para diálisis



ROMERO, CARLOS (ARGCR028130)

ARGCR02 - FME CORDOBA(2) - CASEROS
CASEROS 1715
Cordoba (5000) Argentina
Telefono : (0351) 4885454 / 4885864

TRANSFUSIONES

- No se registran datos

VACUNACION HEPATITIS - B

- No se registran datos

VACUNACION - OTRAS

Fecha de vacunación	Vacuna	Dosis	Unidades
25/02/2021	COVID-19 - Vaxzevria/Covishield (AZD1222/ChAdOx1, Oxford-AstraZeneca)		
21/04/2021	COVID-19 - Vaxzevria/Covishield (AZD1222/ChAdOx1, Oxford-AstraZeneca)		
21/11/2021	COVID-19 - Vaxzevria/Covishield (AZD1222/ChAdOx1, Oxford-AstraZeneca)		


Dr. EDMUNDO VIDELA
COORDINADOR MEDICO
FRESENIUS MEDICAL CARE
ARGENTINA S.A.
ESP. NEFROLOGIA Y MEDIO INTERNO
M.P: 2433878 - M.E: 6828



Nombre Paciente: **ROMERO, CARLOS DANIEL**
 HC: 1237398
 Fecha nacimiento: 11/05/1963
 Espécimen: SANGRE
 Fecha de Extracción / envío: 18/01/2023 07:26
 Médico solicitante: DE LA FUENTE, JORGE LUIS
 Fecha Informe: 18/01/2023 11:40

Donante: **DIP GUSTAVO JAVIER**

Estudio: **Crossmatch vs. Donante por Citometría de Flujo**

IgG anti-Linfocitos T (MCS):	NEGATIVO (<40 MCS)	<40 NEGATIVO
		40-60 CUESTIONABLE
		> 60 POSITIVO
IgG anti-Linfocitos B (MCS):	NEGATIVO (<100 MCS)	<100 NEGATIVO
		100-120 CUESTIONABLE
		> 120 POSITIVO

*MCS: Median Channel Shift

MARTIN ROLLAN LUCILA
 BIOQUIMICA
 M.P. 5779

Hospital Privado

Naciones Unidas 346. B° Parque Velez Sarsfield, Córdoba
Tel: 4688200

Paciente: DIP, GUSTAVO JAVIER Edad: 49
Historia clínica: 1312267 Documento: DNI 23360410

El paciente ha realizado una prueba cruzada por citometría de flujo con el potencial receptor ROMERO CARLOS DANIEL, DNI 16178394, cuyo resultado demuestra compatibilidad inmunológica para permitir la donación de un riñón con fines de trasplante. Dada la ausencia de parentesco, el donante requerirá de autorización judicial para completar la evaluación y el procedimiento.
Sin otro particular, lo saluda atte.

Córdoba, 09/03/2023

Dr. JORGE DE LA FUENTE
JEFE DEL PROGRAMA DE TRASPLANTES
M.P. 255172 - M.E. 41303
NEFROLOGÍA

Firma y sello

Dr. DE LA FUENTE, JORGE LUIS



Hospital Privado
Naciones Unidas 346, Bº Parque Vélez Sarsfield, Córdoba 4083200

ACTA DE INFORMACIÓN SANITARIA

NEFRECTOMÍA PARA DONACIÓN RENAL

En la Ciudad de Córdoba, a 08 días del mes de marzo de 2023, en la sede de HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A. sito en Avda. Naciones Unidas N° 346, Barrio Parque Vélez Sarsfield de esta Ciudad de Córdoba, se reúnen el Dr. DE LA FUENTE, JORGE LUIS, M.P. 25517, M.E. N° 11308 en calidad de nefrólogo del programa de trasplantes renales de la institución, y el/la Sr./a DIP GUSTAVO JAVIER, de nacionalidad ARGENTINO, que se identifica con DNI N° 23360410, de 49 años de edad, con domicilio real en RIO EWAN 2724, Historia Clínica N° 1312267, quien es atendido en esta institución desde el día de la fecha, quien manifiesta y demuestra encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales.

El Dr. DE LA FUENTE, JORGE LUIS informa al/a la Sr./Sra. DIP GUSTAVO JAVIER

ANTECEDENTES MÉDICOS

El motivo inicial de consulta es un cuadro de donación renal.

ESTADO DE SALUD

A evaluar

PROPUESTA TERAPÉUTICA

Además de la información oral facilitado por su médico sobre su enfermedad, usted debe saber que el propósito principal de los detalles transcritos a continuación, es que conozca el procedimiento al que va a ser sometido, las complicaciones más frecuentes del mismo y las alternativas terapéuticas al tratamiento indicado por su doctor. Lea atentamente este documento y consulte con su médico todas las dudas que se le planteen.

Esta terapéutica consiste en una intervención quirúrgica en la cual se le extraerá un riñón con el fin de injertarlo en el receptor que lo requiere como tratamiento para la insuficiencia renal terminal. El riñón que usted tiene voluntad de donar permite brindar al receptor el mejor tratamiento disponible para su enfermedad, tanto en términos de sobrevida como de calidad de vida.

Por imperio de las leyes mencionadas, usted o su representante legal deberá firmar el consentimiento para poder realizarle la intervención.

DETALLES DE LA INTERVENCIÓN

La nefrectomía consiste en una intervención quirúrgica en la cual se le extraerá un riñón con el fin de injertarlo en el receptor. La cirugía dura entre 2 a 5 horas y luego requerirá de una internación de aproximadamente 2 días en una habitación común. Luego del alta deberá concurrir a controles ambulatorios según las indicaciones médicas.

Para la cirugía se le aplicará anestesia general. Si Ud. tiene alergia a la anestesia o a algún otro medicamento, deberá informarlo con toda precisión a los profesionales tratantes en forma previa a la realización cualquier procedimiento.

La nefrectomía del donante es realizada por el equipo de cirujanos urólogos del programa de trasplante renal integrado por: Dr. Joaquín Álvarez Garzon, Dr. Raul Colla, Dr. Esteban Metrebian, Dr. Sergio Metrebian, Dr. Martín Revol y Dr. Alejandro Sosa.

RIESGOS PROBABLES

Toda intervención quirúrgica lleva implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían hacer variar la técnica operatoria programada, requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad.

Las complicaciones de este tratamiento serán principalmente las derivadas del acto quirúrgico y las relacionadas con la disminución de la reserva renal.

Las posibles complicaciones quirúrgicas y del perioperatorio son:

- 1- Derivadas de la anestesia: reacciones alérgicas a anestésicos, dificultad de intubación y otras. La mortalidad de esta técnica se estima que puede ser 2 de cada 10.000 pacientes.
- 2- Derivadas de la incisión quirúrgica: hemorragias, infecciones, eventraciones y parestesias.
- 3- Derivadas del postoperatorio: infecciones de la herida, infecciones respiratorias, tromboembolismo pulmonar y otras.

Algunas de estas complicaciones podrían requerir reintervenciones quirúrgicas, terapia intensiva y la administración de productos derivados de la sangre.

La mortalidad global de todo el procedimiento en centros con experiencia es inferior a 3 cada 10.000 cirugías.

En nuestro centro con más de 700 trasplantes con donante vivo realizados no registra mortalidad en donantes lo que está en consonancia con estas estadísticas.

Las posibles complicaciones relacionadas con la disminución de la reserva renal son:

- La extracción de un riñón disminuye su reserva renal. Según los datos de diferentes

registros internacionales de donantes renales, este procedimiento es seguro en el largo plazo con estudios a más de 40 años pos donación en la que la sobrevida, la aparición de eventos cardiovasculares (infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, etc) y de enfermedades neoplásicas es similar a la de la población sana que no donó un riñón. Existe si un aumento leve de la presión arterial (aprox 5 mmHg) y aparición más frecuente de albúmina en orina. En dos estudios recientes se muestra un aumento en la incidencia de enfermedad renal crónica terminal (y riesgo cardiovascular) en los donantes (0,02% y 0,24%), principalmente asociados a la presencia de enfermedades inmunológicas en el receptor de donantes relacionados genéticamente y a la raza negra. El riesgo estimado de enfermedad renal terminal a lo largo de la vida en el donante es inferior al 1% e inferior al de la población general.

- En relación al embarazo post donación existe un incremento en la incidencia de hipertensión gestacional (11% comparado con 5% en mujeres no donantes) sin otra complicación asociada.

RIESGOS PROPIOS DEL PACIENTE

Edad mayor de 60 años	Si	No
Hábito tabáquico	Si	No
Obesidad	Si	No
Hipertensión arterial	Si	No
Glucemia alterada en ayunas	Si	No
Déficit de la coagulación o uso de antiCO-antiagregantes	Si	No
Alergia a la anestesia	Si	No
Historia de cardiopatía isquémica	Si	No
Historia de IC compensada	Si	No
Historia de ACV	Si	No

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS

Existen otras alternativas terapéuticas para tratar la insuficiencia renal crónica terminal del receptor, sin necesidad de realizar una nefrectomía a un donante vivo, ellas son: hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante renal de un donante cadavérico. Aunque el tratamiento con mejores resultados es el trasplante renal proveniente de un donante vivo.

CONSECUENCIAS PREVISIBLES A LA NEGACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

A este procedimiento se accede voluntariamente, sabiendo que no es imprescindible para la vida del receptor, ya que está recibiendo otro tratamiento para su insuficiencia renal terminal (diálisis).

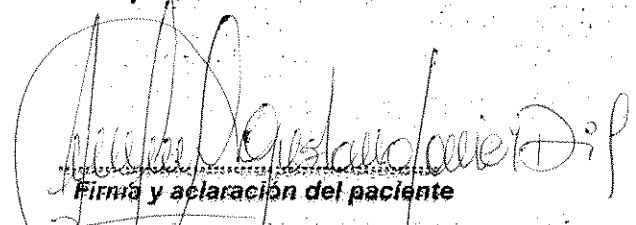
Es importante conocer también que Usted tiene derecho a decidir no donar en cualquier momento del proceso hasta el instante mismo del comienzo de la cirugía.

RESULTANDO LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA INDISPENSABLE PARA PERMITIR AL PACIENTE y/o a su REPRESENTANTE LEGAL EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONTENIDOS EN LAS LEYES 26.529 Y 26.994 y EN BASE A ELLO PODER BRINDAR EL CONSENTIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN O NO DE LOS PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS PROPUESTOS, se procede a interrogar al Sr. DIP , GUSTAVO JAVIER, sobre la comprensión de lo que ha sido explicado, instándolo a que efectúe todas las preguntas que satisfagan sus interrogantes, las que son contestadas a su satisfacción.

Prevía lectura y ratificación, las partes suscriben la presente acta que se instrumenta en dos copias, una de las cuales se entrega al Sr. DIP , GUSTAVO JAVIER, adjuntándose la restante a las constancias de su Historia Clínica.

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento.

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice el procedimiento anteriormente descripto.


Firma y aclaración del paciente

Firma y sello del médico

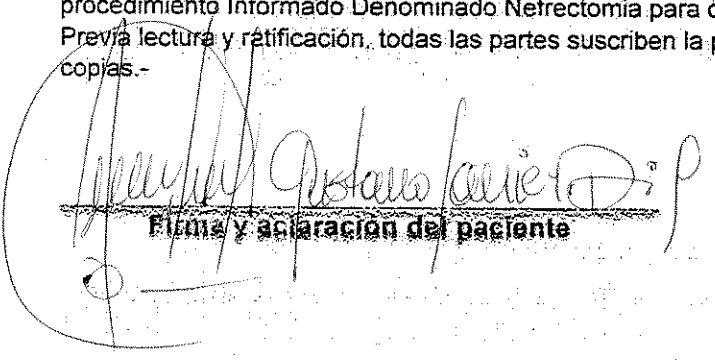
Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.).

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En la Ciudad de Córdoba, a los 08 días del mes de marzo de 2023, siendo las 12:29 hs. hs. el/la Sr./Sra. DIP GUSTAVO JAVIER manifiesta que ha reflexionado detenidamente sobre la información contenida en el Acta de Información Sanitaria que le fuera entregada con fecha 08/03/2023. En relación a la misma, en ejercicio de las facultades conferidas en los Arts. 2, inc. e), 3 y 5 de la Ley 26.529 y artículo 59 de la ley 26.994 expresa:

Que autoriza al Dr. DE LA FUENTE, JORGE LUIS y a su equipo profesional a realizarme el procedimiento Informado Denominado Nefrectomía para donación renal

Prevía lectura y ratificación, todas las partes suscriben la presente acta que se instrumenta en dos copias.-


Firma y aclaración del paciente

Apellido / Su
ROMERO

Nombre / Name
CARLOS D/

Sexo / Sex
Nacionalidad / Nationality
ARGENTINA

ments / Date of birth
MAY 1963

Printed on / Date of Issue
01/01/2021

Expiry Date / Date of expiry
12 NOV / NOV 2038

FIRMA IDENTIFICADO/ SIGNATURE

Documento / Document

16:178.394

Tramite N° / Of. Ident.

006816 10916
8295

12 NOV / NOV 2030

12 NOV / NOV 2030

Tramite N° / Of. Ident.
00681610916
8296

Trémie N° / Cl. Ident.
00681610916
8296

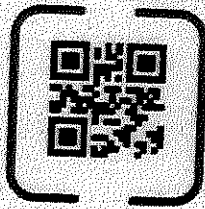
DOMINGO, LOS TEROS 53, LOMAS DEL REY
SUMAJ, PUNTA DE CORDOBA
LUGAR DE MADRUGADA, CORDOBA

CUL: 20-16178384-4

Dr. Eduardo E. de Pa
Ministro del Interior

PULGAR

IDARG16178394<7<<<<<<<<<<<<<<
6305110M361112ZARG<<<<<<<<<<<<<<4
ROMERO<<CARLOS<DANIEL<<<<<<<<<<<<



ROMERO CARLOS
DANIEL

Nº AFILIACIÓN

140056835204/00

4

📱 f 📧 pami.org.ar

50 PAMI INSSJP
cincuenta años 1971-2021

📞 138 PAMI escucha y responde

5

En la ciudad de Ushuaia, a los 29 días del mes de marzo, siendo la hora 17:00, comparece ante esta DPO el Sr. Gustavo Javier Dip, quien acredita su identidad con DNI Nro. 23.360.410, a pedido del Sr. Defensor Dr. José G. Bongiovanni. Abierto el acto, el compareciente manifiesta: que solicita ser asistido por esta DPO para solicitar una autorización judicial para que se le permita donar un riñón a su amigo, el Sr. Carlos Daniel Romero, DNI Nro. 16.178.394, quien actualmente se encuentra residiendo en la ciudad de Córdoba. Dice, que ya se ha hecho todos los estudios de histocompatibilidad en la clínica de la ciudad de Córdoba, lugar donde se realizará la ablación. Que ya ha prestado su consentimiento informado en relación a las consecuencias de realizar la donación. Que su decisión obedece a que es amigo del receptor del órgano, y que lo hace por solidaridad y altruismo, motivado además por su fe cristiana evangélica. Agrega que no ha recibido ni recibirá un beneficio económico por la donación que pretende hacer. En este acto, el Sr. Defensor lo interroga acerca del motivo de su decisión de realizar la donación y sobre su conocimiento acerca de las eventuales consecuencias médico-clínicas que pudieran acontecer sobre su salud en el futuro, a lo que el compareciente se remite a lo ya manifestado previamente. Finalmente, se le hace saber que esta DPO lo asistirá técnicamente a los fines de lograr la autorización judicial que dispone la ley 27.447, por lo que se presentará oportunamente la petición ante el juzgado federal de esta ciudad. Con lo que terminó el acto, firmando el compareciente, previa lectura y ratificación de la presente, ante mí, de lo que doy fe.-




Gustavo Javier Dip
DNI 23360410


MATIAS AGUSTIN CIU
Secretario


JOSE BONGIOVANNI
Defensor Público Oficial



Carlos Daniel Romero

DNI 16 17 8394

Paciente de 59 años de edad
portador de Insuficiencia
Renal Crónica secundaria
a Nefropatía crónica con
Hemodiálisis desde el
31/10/2020, actualmte
ingrupto en bits de aspersa

para tener parte con el por propia
elección.

Permanente artículo hoy o
futuro.



Dr. EDMUNDO VIDELA
COORDINADOR MÉDICO
FRESENIUS MEDICAL CARE
ARGENTINA S.A.
ESP. NEFROLOGÍA Y MEDIO INTERNO
M.P. 24336/6 - M.E. 8928

Acordado

22/02/2023

